



CLÍNICA MARQUES DOS SANTOS

Manual do Colaborador

Uma nova perspectiva de cuidar.

Tudo o que precisas para trabalhar connosco — passo a passo, sem depender de memória. Do primeiro atendimento à última sessão, sempre da mesma forma cuidada.

- O protocolo é o teu formador.
- Se não está escrito, não existe.
- Na dúvida, pergunta — melhorar este manual também é cuidar.

Bem-vindo(a) à Clínica Marques dos Santos

Este manual é o teu mapa. A clínica funciona como um **sistema organizado**: o conjunto de regras, protocolos, ferramentas e rotinas que permite cuidar de cada pessoa com o mesmo rigor, todos os dias. Na prática, isto significa uma coisa muito boa para ti: **nunca vais depender da memória, de adivinhar, nem de perguntar tudo a toda a hora**. Cada tarefa tem instruções escritas, cada ferramenta tem um papel, e cada dúvida tua é uma oportunidade de melhorar o manual.

A arquitetura — cada peça tem um papel

Software de gestão O cérebro. Agenda, fichas clínicas e faturação num só lugar.	Ficha clínica A memória de cada paciente. Tudo o que se sabe, escrito.	Protocolos (SOPs) As receitas passo a passo de cada tarefa.
Agenda O coração do dia. Quem vem, quando e com quem.	Receção A primeira e a última cara que o paciente vê.	Checklists O sistema de segurança. Impedem esquecimentos e erros.
Faturação e reembolsos ADSE, SAMS, seguros e recibos — sem erros.	Comunicação Telefone, email e WhatsApp Business — um canal, uma voz.	Redes sociais Instagram e Facebook — a montra da clínica.
Cofre de acessos Todas as palavras-passe, num só lugar seguro.	Revisões A melhoria contínua. Momentos fixos para corrigir e melhorar.	Equipa clínica Fisioterapeutas, osteopatas e mais — o cuidado em pessoa.

Como trabalhamos: a simplicidade vence sempre

Sempre que existirem duas formas de executar uma tarefa, escolhe-se a mais simples, desde que seja segura e cuide bem do paciente. Nada entra no nosso trabalho sem responder «sim» a pelo menos uma das **7 perguntas**:

1. Poupa tempo?	5. Permite delegar com segurança?
2. Reduz erros?	6. Pode simplificar-se ou automatizar-se?
3. Facilita o atendimento?	7. Melhora a experiência do paciente?
4. Melhora a qualidade do cuidado?	Se «não» a todas: elimina-se .

O TESTE DOS 60 ANOS — A NORMA DE QUALIDADE DA CASA

«Uma pessoa portuguesa com cerca de 60 anos, que apenas utiliza o computador para consultar emails, navegar na internet e editar documentos simples, consegue seguir estas instruções sem pedir ajuda?» Foi assim que este manual foi escrito — e é assim que vais escrever as melhorias que propuseres. Se leres uma secção e não perceberes, a culpa **não é tua: é do manual**. Diz-nos, e corrigimos.

Como utilizar este manual

- **Não é para ler de uma vez.** Na primeira semana, os Módulos 00, 04 e 13 chegam.
- Cada módulo é independente — consulta-se quando é preciso.
- É um **documento vivo**: cada atendimento pode melhorar uma linha.
- **O sistema protege-te**: quem segue os protocolos nunca depende de memória nem leva culpas injustas — o que está escrito defende-te.

Índice do manual

Quinze módulos. Cada um responde a uma pergunta do teu dia a dia.

Módulo	Nome	A pergunta a que responde
00	Começar Aqui	O que faço na primeira semana?
01	Centro de Comando	O que devo olhar e fazer hoje?
02	A Clínica	O que fazemos, para quem e porquê?
03	Operações Clínicas	Como cuido com qualidade, sempre da mesma forma?
04	Pacientes	Como falamos (e não falamos) com pacientes?
05	Marcações e Agenda	Como se gere a agenda, as marcações e as faltas?
06	Serviços e Especialidades	O que está no catálogo e o que respondo a pacientes?
07	Protocolos (SOPs)	Onde estão as instruções de cada tarefa?
08	Faturação e Reembolsos	Como se cobra, se emite recibo e se pede reembolso?
09	Registos e Conhecimento	Onde guardo o que registo e como nomeio ficheiros?
10	Reporte	O que comunico, a quem e quando?
11	Rotinas e Revisões	Quais são os meus rituais diários e semanais?
12	Integração e Evolução	Como ganho autonomia e cresço na equipa?
13	Segurança e Confidencialidade	O que devo proteger sempre — sem exceções?
14	Modelos	Que templates uso no dia a dia?

O teu primeiro dia — passo a passo

- Recebe os teus acessos** do responsável: email de trabalho, convite para o cofre de palavras-passe e acesso ao software de gestão da clínica (agenda e fichas).
- Ativa a verificação em 2 passos (2FA)** no email e no cofre — o responsável mostra como; demora 5 minutos e é obrigatório.
- Faz a **visita guiada ao espaço**: receção, gabinetes, estúdio de pilates, zona de higienização, saídas de emergência e mala de primeiros socorros.
- Resultado esperado**: consegues abrir a agenda do dia, ver as consultas marcadas e identificar cada gabinete e cada colega de serviço.
- Como confirmar**: abre a agenda de hoje — deve mostrar os pacientes por hora e profissional. Se algo não abrir, diz ao responsável nesse momento (não «fica para depois»).
- Lê o resto deste Módulo 00 e os Módulos 04 (Pacientes) e 13 (Segurança). É a tua leitura do dia 1 — mais nada.

AS 3 REGRAS DIÁRIAS (VALEM PARA TODOS, INCLUINDO A DIREÇÃO)

1. Tudo entra na agenda ou na ficha. Pedido, recado, alteração — regista-se no momento, no sítio certo. Nada fica «na cabeça». **2. Se não está escrito, não existe.** Combinados com pacientes e colegas escrevem-se na hora. **3. À terceira repetição, propõe-se simplificar.** Tarefa manual feita 3 vezes regista-se como proposta de melhoria.

O QUE NÃO FAZER (EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA)

Não alterar protocolos por conta própria — propor melhorias sim, editar não. Não guardar palavras-passe em notas ou mensagens (só no cofre). Não usar contas ou números pessoais para falar com pacientes. Não apagar registos clínicos — na dúvida, pergunta. Não dar diagnósticos, preços ou prazos que não estão confirmados (Módulos 04 e 08). Não falar de pacientes fora da clínica: estamos obrigados ao sigilo.

Glossário básico — os termos explicados de forma simples

Termo	O que significa
Ficha clínica	O registo de tudo o que diz respeito a um paciente: dados, avaliações, sessões e evolução.
Episódio	Um motivo de tratamento com início, plano e alta (ex.: «lombalgia — 8 sessões»).
Anamnese	A recolha inicial da história do paciente: queixa, antecedentes e objetivos.
Triagem	Perceber, à entrada, qual a especialidade e a urgência certas para o paciente.
Protocolo / SOP	Procedimento Operacional Padrão: a receita passo a passo de uma tarefa.
Reavaliação	Momento fixo (ex.: a cada 4 sessões) para medir progresso e ajustar o plano.
Consentimento informado	Autorização escrita do paciente depois de lhe ser explicado o que vai ser feito.
No-show / falta	Paciente que não comparece nem avisa. Tem regras próprias (Módulo 05).

Termo	O que significa
Reembolso / comparticipação	Parte do valor que a ADSE, os SAMS ou um seguro devolvem ao paciente mediante recibo.
Fatura-recibo	Documento oficial da consulta, com os dados fiscais do paciente. Base de qualquer reembolso.
Fisiatra	Médico de Medicina Física e de Reabilitação. Prescreve e valida planos para reembolso.
Cofre de acessos	Programa onde ficam guardadas todas as palavras-passe da clínica, de forma segura.
Sigilo profissional	Dever de nunca revelar informação de um paciente. Vale durante e depois da colaboração.
Dados de saúde	Informação clínica. É uma categoria especial do RGPD — protege-se com o máximo cuidado.
RGPD	Lei europeia de proteção de dados. Obriga a consentimento, sigilo e segurança.
Higienização	Limpeza e desinfecção do gabinete e do material entre pacientes. Nunca se salta.

As ferramentas que vais usar

Ferramenta	Para que a usas	Quando
Software de gestão	Ver a agenda, marcar, abrir e atualizar fichas clínicas, faturar	Todos os dias
Cofre de acessos	Aceder a palavras-passe partilhadas contigo	Todos os dias
Telefone / WhatsApp Business	Marcar, confirmar e responder a pacientes pelo canal oficial	Todos os dias
Email de trabalho	Confirmações, envio de recibos e documentos de reembolso	Todos os dias
Terminal de pagamento	Receber pagamentos e emitir o comprovativo	Ao fim de cada consulta
Portais ADSE / SAMS / seguros	Validar comparticipações e submeter reembolsos	Quando aplicável
Instagram / Facebook	Publicar conteúdo aprovado e responder a mensagens	Em comunicação

ANTES DE TOCARES NUM PACIENTE OU NUMA FICHA

Confirma sempre três coisas: **é a pessoa certa** (nome e data de nascimento), **é a consulta certa** (especialidade e profissional na agenda) e **o gabinete está higienizado e preparado**. Trinta segundos que evitam 90% dos enganos.

O que a agenda te mostra (e nada mais)

- **As tuas 3 prioridades do dia** — nunca mais de 3, escritas por ti todas as manhãs.
- **Consultas de hoje** por hora, profissional e gabinete.
- **Confirmações pendentes** e primeiras consultas (que precisam de mais tempo).
- **Alertas** — faltas por remarcar, reembolsos por submeter, pacientes sem resposta há 2+ dias.

A matriz de decisão — contra a sobrecarga mental

Perante qualquer tarefa nova, percorre estas perguntas **por esta ordem**:

Pergunta (por ordem)	Se a resposta mandar, a ação é
1. Acrescenta valor ao paciente ou à clínica? Se não...	ELIMINAR (confirma antes com o responsável)
2. Já foi feita 3+ vezes e é repetitiva?	PROPOR SIMPLIFICAR (fila de melhorias)
3. Está acima da tua alçada (clínica, preço, promessa)?	ESCALAR ao responsável
4. Tem de ser feita hoje? Se não...	AGENDAR (com data, nunca «logo se vê»)
5. Sobrou?	FAZER (entra nas 3 prioridades)

Os 5 tipos de trabalho — para saberes onde está o teu dia

Tipo	O que é	O teu papel
Clínico	Avaliações e sessões com pacientes, seguindo protocolos.	O teu foco principal (se és da equipa clínica)
Atendimento	Receção, agenda, telefone, pagamentos e reembolsos.	O teu foco principal (se és da receção)
Administrativo	Emails, organização, arrumação de registos.	1 bloco fixo por dia
Melhorável	Repetitivo ou confuso.	Regista e propõe (fila de melhorias)
Eliminável	Não passa nas 7 perguntas.	Zero

REGRA 80/20

80% dos resultados vêm de 20% das tarefas. As tuas 3 prioridades diárias saem desses 20% — quase sempre trabalho clínico ou de atendimento com hora marcada, quase nunca administrativo.

Um dia típico na clínica

Para veres como os módulos encaixam na prática. Os horários são um exemplo — o que é fixo são os rituais. A clínica abre das **09:00 às 20:00** (sábado até às 13:00).

08h45 Abertura (10 min)	Abrir a clínica · ligar sistemas · conferir a agenda do dia · escrever as 3 prioridades. Gabinetes higienizados e prontos.
09h00 Primeiras consultas	Acolhimento, check-in e primeiras sessões, com o protocolo à mão. As avaliações iniciais têm mais tempo reservado.
11h30 Pacientes e comunicação	Responder dentro do prazo de 1 dia útil · confirmar consultas do dia seguinte · atualizar fichas à medida que avanças.
13h00 Pausa / almoço	A sério. O sistema funciona precisamente para ninguém almoçar a olhar para o ecrã.
14h00 Bloco da tarde	Consultas e sessões · marcar as checklists na ficha à medida que avanças · reavaliações agendadas.
18h30 Faturação e reembolsos	Emitir recibos em falta · submeter reembolsos · confirmar pagamentos do dia · tratar remarcações.
19h50 Fecho (10 min)	Fecho de caixa · check-in do dia no canal interno: o que correu bem · o que ficou pendente · o que preciso amanhã.

À SEXTA-FEIRA

O último bloco dá lugar aos rituais semanais: resumo da semana, conferência de reembolsos submetidos, pendentes e o bloco administrativo (Módulo 11). É também o dia de rever o stock de material clínico e consumíveis.

O BLOCO MAIS VALIOSO DO DIA

A primeira consulta da manhã com um paciente novo define a relação inteira. Telemóvel em silêncio, ficha lida antes de o chamar, tempo para ouvir. Vale por dez sessões apressadas.

Quem somos

Missão	Uma nova perspectiva de cuidar: tempo, rigor e um plano à medida para cada pessoa, do primeiro dia à última sessão.
O que fazemos	Fisioterapia, osteopatia e mais de vinte consultas e especialidades médicas, em Castelo Branco.
Quem cuidamos	Pessoas com dor, lesão ou em recuperação — e quem procura prevenção, bem-estar e acompanhamento próximo.
O que nos distingue	Acompanhamento próximo com qualidade constante — porque trabalhamos por sistema, não por imprevisto. Médico fisiatra para reembolsos ADSE/SAMS. Este manual é a prova.

O catálogo de serviços

Serviço	Valor de referência	Tipo
Avaliação inicial (fisioterapia)	conforme tabela	Pontual
Sessão de fisioterapia	conforme tabela	Plano de sessões
Osteopatia	conforme tabela	Pontual / plano
Consultas de especialidade (psicologia, nutrição, fisiatra...)	conforme tabela	Pontual / recorrente
Pilates clínico / treino personalizado	conforme tabela	Recorrente (mensal)
Palmilhas personalizadas / podologia	conforme tabela	Pontual

IMPORTANTE — PREÇOS E ÂMBITO

Esta tabela serve para dares contexto, nunca para fechares valores. **A tabela de preços oficial em vigor prevalece sempre;** preços finais, pacotes e descontos são confirmados pela direção. Se um paciente pedir algo fora do catálogo, a resposta certa é: «Boa pergunta — deixe-me confirmar e respondo ainda hoje.»

PORQUE É QUE O ACOMPANHAMENTO IMPORTA

Planos completos e consultas de continuidade (reavaliações, pilates, manutenção) são o que dá estabilidade à clínica — e ao teu posto. O teu papel: cuidar tão bem que a próxima sessão se marca sozinha. Um paciente que se sente ouvido volta, e recomenda.

A jornada do paciente — 7 estados, sempre pela mesma ordem

contacto	marcado	em avaliação	em tratamento	reavaliação	alta	seguimento
Estado	O que significa			Só avança quando...		
contacto	Pedido recebido, ainda por marcar			Consulta marcada e confirmada		
marcado	Data marcada, à espera do dia			Paciente comparece e faz check-in		
em avaliação	Avaliação inicial e plano			Plano de tratamento definido e explicado		
em tratamento	Sessões a decorrer (é aqui que mais trabalhas)			Atingido o marco de reavaliação		
reavaliação	Medir progresso e ajustar			Objetivos cumpridos ou plano revisto		
alta	Objetivos atingidos, alta dada			Alta registada e explicada ao paciente		
seguimento	Acompanhamento ou manutenção			—		

REGRA DE OURO DAS OPERAÇÕES

Nunca se inicia um tratamento sem **avaliação feita e consentimento registado**, e nunca se avança de plano sem **reavaliação**. Antes de pegares numa sessão, confirma na ficha: avaliação e consentimento «sim». Se estiver «não», pára e pergunta.

Controlo de qualidade — checklist antes e depois de cada consulta

É a tua rede de segurança. Executa-a sempre, mesmo com pressa — sobretudo com pressa:

- [] Paciente certo confirmado (nome + data de nascimento).
- [] Ficha lida antes da consulta; consentimento e contraindicações verificados.
- [] Gabinete e material higienizados antes e depois.
- [] Sessão registada na ficha no próprio dia (o que se fez e a resposta).
- [] Próxima sessão marcada e pagamento/recibo tratados.
- [] O paciente sabe o que fazer em casa (exercícios, cuidados, sinais de alerta).

Fecho de um episódio — sempre os mesmos 4 passos

1. **Alta e resumo** (protocolo de alta): objetivos atingidos, recomendações e plano de manutenção, explicados ao paciente.
2. **Testemunho / avaliação** — pede-se na alta, com a satisfação fresca (o responsável indica quando e quem pede).
3. **Proposta de continuidade** — reavaliação futura, pilates ou manutenção, quando faz sentido clínico.
4. **Registo final na ficha** — para que qualquer colega perceba o caso em segundos, hoje ou daqui a um ano.

AS 3 REGRAS DA COMUNICAÇÃO (INEGOCIÁVEIS)

1. Um canal único e oficial por paciente (telefone/WhatsApp Business OU email — nunca números pessoais). **2. Empatia primeiro:** ouve, confirma que percebeste, só depois responde. Quem chega com dor chega também com receio. **3. Prazo de resposta: 1 dia útil.** Se não tens a resposta, responde na mesma: «recebi, estou a tratar, respondo até X».

O que podes decidir vs. o que escala sempre

Podes decidir tu	Escala SEMPRE ao responsável / profissional
Marcar, remarcar e organizar a agenda dentro das regras.	Diagnósticos, alterações ao plano clínico ou a exercícios.
Explicar como decorre uma consulta e o que trazer.	Preços, pacotes, descontos e condições de pagamento.
Responder a dúvidas simples já cobertas por protocolo ou FAQ.	Promessas de resultados ou prazos de recuperação.
Encaminhar para o profissional certo por triagem.	Queixas, insatisfação, tom agressivo ou incidentes.
	Qualquer pedido de aconselhamento clínico fora da tua função.

A FRASE MÁGICA PARA ESCALAR SEM PERDER O PACIENTE

«Boa pergunta — deixe-me confirmar com o profissional/equipa e respondo ainda hoje.» Nunca digas «não sei», nunca inventes um conselho clínico, nunca digas «sim» só para agradar. Regista o pedido na ficha e avisa a pessoa certa no momento.

Como funciona a marcação (contexto para perceberes o processo)

O paciente chega por telefone, WhatsApp, formulário do site ou presencialmente. Faz-se uma **triagem simples** (qual a queixa, que especialidade, que urgência) e marca-se com o profissional certo. A **primeira consulta é sempre uma avaliação** e reserva mais tempo. O plano de tratamento e o número de sessões saem dessa avaliação — nunca se prometem de antemão. Casos que envolvam reembolso ADSE/SAMS podem precisar de **prescrição do fisiatra**: confirma sempre antes (Módulo 08).

Depois da consulta

- **Confirmação:** a próxima sessão fica marcada antes de o paciente sair, sempre que possível.
- **Lembrete:** o sistema envia um lembrete automático na véspera; a receção confirma os casos sem resposta.
- **Continuidade:** reavaliação, manutenção ou nova especialidade são propostas pelo profissional, nunca «empurradas».

Os estados de uma marcação

pedido	confirmada	realizada	faturada	reembolso submetido
--------	------------	-----------	----------	---------------------

As regras da agenda

- **Cada marcação tem: paciente, especialidade, profissional, gabinete e duração.** Faltando um, a marcação não está completa.
- **Primeiras consultas reservam mais tempo** — nunca encaixar uma avaliação num espaço de sessão.
- **Confirmação na véspera:** o sistema envia lembrete; a receção confirma os que não responderam.
- **Sobrelotação não existe:** se a agenda de um profissional está cheia, encaixa-se noutra ou propõe-se a data seguinte — nunca se marca «por cima».

Faltas e remarcações

Situação	O que fazes
Paciente pede para remarcar	Remarca no momento, atualiza a agenda e liberta o horário para outro paciente.
Paciente avisa que não vem	Regista a falta justificada e reagenda. O horário livre entra na lista de espera.
Falta sem aviso (no-show)	Regista na ficha, contacta o paciente para reagendar e aplica a política de faltas em vigor.
Lista de espera	Quando abre um horário, contacta-se por ordem quem está à espera dessa especialidade.

NUNCA PROMETAS O QUE A AGENDA NÃO TEM

Se um paciente insiste por um horário que não existe, a resposta é: «não tenho essa vaga, mas deixe-me ver a primeira disponível e ligo-lhe ainda hoje.» Nunca marques «à força» nem sobreponha consultas — isso quebra o dia inteiro da equipa.

O QUE O SISTEMA FAZ SOZINHO — E O TEU PLANO B

Os **lembretes de consulta** saem automaticamente na véspera. Se o envio falhar, o plano B é simples: a receção telefona a confirmar as consultas do dia seguinte, a partir da agenda. A clínica abrandar, não pára.

Cada serviço tem uma ficha na Biblioteca. Antes de atenderes sobre um serviço pela primeira vez, lê a ficha dele — diz-te o que está incluído, o que não está, quanto tempo demora e qual o protocolo a seguir:

```
---
tipo: servico
nome: Fisioterapia
avaliacao_inicial: sim
reembolso: [ADSE, SAMS, seguros]
prescricao_fisiatra: quando aplicável
protocolo: "[[Protocolo - Fisioterapia]]"
---

## O que promete (uma frase, na linguagem do paciente)
## O que inclui / não inclui
## Duração típica e nº de sessões
## Perguntas frequentes do paciente
```

O que o paciente recebe em cada serviço

Serviço	O que o paciente recebe	Duração típica
Fisioterapia	Avaliação, plano à medida e sessões com reavaliação a cada 4.	6–12 sessões
Osteopatia	Avaliação global e técnicas manuais, integradas com o plano.	Caso a caso
Reabilitação perineal	Avaliação especializada e treino funcional, em gabinete reservado.	6–10 sessões
Psicologia / nutrição	Consulta individual e plano de acompanhamento.	Recorrente
Pilates clínico	Aulas orientadas em pequeno grupo ou individuais.	Mensal
Podologia / palmilhas	Avaliação do apoio e palmilhas personalizadas.	1–2 consultas

Respostas-tipo a perguntas frequentes

O paciente pergunta	A resposta certa
«Isto fica mais barato se fizer um pacote?»	«As condições estão na nossa tabela — deixe-me confirmar e digo-lhe ainda hoje.»
«Quantas sessões vou precisar?»	«Isso define-se na avaliação inicial — não seria sério dizer-lhe um número sem avaliar.»
«A ADSE paga?»	«Há comparticipação; confirmo o seu caso e o que precisa (pode ser preciso o fisiatra) e explico tudo.»
«Posso ser visto hoje?»	Confirmar a agenda antes de responder — nunca prometer horários de cabeça.
«Isto vai doer?»	«O profissional explica-lhe tudo antes de começar e ajusta ao seu conforto — está em boas mãos.»

Um protocolo é a receita de uma tarefa, escrita para que qualquer pessoa a execute sem pedir ajuda. É a tua principal ferramenta de trabalho — e a razão pela qual nunca vais ouvir «devias saber isso»: se não está no protocolo, a falha é do sistema, não tua.

Como executar um protocolo (o teu ritual)

1. Abrir o protocolo e **ler do princípio ao fim antes de começar** — nunca executar a ler pela primeira vez.
2. Confirmar os **pré-requisitos** (paciente certo, consentimento, material, gabinete).
3. Seguir os passos **pela ordem**, marcando a checklist na ficha.
4. Comparar o resultado com o **«resultado esperado»** do protocolo.
5. **Se um passo não bater certo com a realidade: pára e pergunta.** Não improvises — em saúde, o imprevisto de hoje é o risco de amanhã.
6. No fim, registar qualquer melhoria ou dúvida (secção «Registo de melhorias»).

O modelo oficial (todos os protocolos têm esta estrutura)

```
---
tipo: protocolo
estado: ativo      # rascunho | ativo | em revisão | arquivado
area: clínica      # clínica | atendimento | faturação
responsavel: [dono deste protocolo]
versao: "1.0"
ultima_revisao: 2026-07-21
---

# Protocolo - [Nome da tarefa]
## Objetivo (o que produz e porquê - uma frase)
## Pré-requisitos (paciente, consentimento, material)
## Passos (1 passo = 1 ação; indica onde e como)
## Resultado esperado (como se sabe que ficou bem feito)
## Erros comuns (o que costuma correr mal e como resolver)
## Registo de melhorias (AAAA-MM-DD - o que mudou e porquê)
```

AS TUAS DÚVIDAS SÃO OURO

Cada dúvida que tiveres ao executar um protocolo é uma melhoria por escrever. Propor melhorias aceites é a forma mais visível de cresceres na equipa (Módulo 12) — o manual só é bom porque quem o usa o corrige.

A biblioteca de protocolos (o que existe hoje)

#	Protocolo	Resumo do processo
1	Atendimento e marcação	Triagem › escolha da especialidade › marcação › confirmação › lembrete.
2	Acolhimento e check-in	Receber, confirmar identidade e dados, encaminhar para o gabinete certo.
3	Avaliação inicial	Anamnese › avaliação › consentimento › plano › explicação ao paciente.
4	Higienização de gabinete	Limpeza e desinfecção de superfícies e material entre pacientes.
5	Faturação e recibo	Cobrança › fatura-recibo › comprovativo › registo na ficha.

#	Protocolo	Resumo do processo
6	Pedido de reembolso	ADSE / SAMS / seguros: documentos, submissão e registo do estado.
7	Remarcação e faltas	Remarcar, tratar no-shows e gerir a lista de espera.
8	Fecho de caixa e fecho da clínica	Conferência de pagamentos, fecho do dia e encerramento seguro do espaço.

QUEM É O DONO DE CADA PROTOCOLO

Cada protocolo tem um campo **responsavel**. Esse campo é o mapa de quem faz o quê: se tens uma dúvida sobre uma área, o dono do protocolo é a pessoa a quem perguntar. Os protocolos clínicos pertencem aos profissionais da especialidade; os de atendimento e faturação, à receção e à direção.

NUNCA SE ALTERA UM PROTOCOLO CLÍNICO POR CONTA PRÓPRIA

Um protocolo clínico protege o paciente e a equipa. Propor melhorias é encorajado; alterá-lo sem validação do profissional responsável, nunca. Enquanto a mudança não está escrita e aprovada, executa-se o que está — mesmo que aches que há forma melhor. Depois propõe, com o porquê.

O PROTOCOLO DEFENDE-TE

Quem segue o protocolo e marca a checklist tem sempre como mostrar o que fez e porquê. Num ambiente de saúde, esse registo é a tua melhor proteção — e a garantia de que o paciente recebe sempre o mesmo cuidado, independentemente de quem está de serviço.

Cada consulta termina com um pagamento e uma **fatura-recibo**. Esse documento é a base de qualquer reembolso — por isso os dados fiscais do paciente têm de estar certos. Tu não precisas de decidir preços; precisas de saber cobrar, emitir e submeter, e o que fazer quando algo falha.

AS 3 REGRAS (A TUA VERSÃO)

1. Dados fiscais certos antes de faturar — nome, NIF e entidade (ADSE/SAMS/seguro) confirmados com o paciente. **2. Recibo emitido no dia da consulta** — nunca «fica para depois». **3. Preços e descontos escalam sempre** — a tabela em vigor e a direção decidem, tu aplicas.

Comparticipações — o que faz e o teu plano B se falhar

Entidade	O que faz	Plano B se falhar (fazes tu)
ADSE	Comparticipa consultas e sessões elegíveis, mediante recibo (e prescrição do fisiatra quando exigida).	Emitir a fatura-recibo com os dados certos e explicar ao paciente como submeter.
SAMS	Comparticipa segundo as suas regras próprias.	Confirmar a tabela SAMS em vigor e entregar o recibo detalhado.
Seguros de saúde	Pagamento direto ou reembolso, conforme a apólice.	Se o portal falhar, faturar particular e entregar recibo para o paciente submeter.
Particular	Paciente paga o valor de tabela.	Emitir recibo e, se pedido, o documento para o seguro.

Quando um pagamento ou portal falha

1. Não entrar em pânico nem improvisar valores.
2. Ativar o plano B: faturar de forma que o paciente não fique preso à espera do sistema.
3. Registar na ficha: data, o que falhou, o que fizeste.
4. Avisar o responsável no canal interno, com a ligação para o registo.

NUNCA IMPROVISES REEMBOLSOS OU PRESCRIÇÕES

Se um paciente precisa de prescrição do fisiatra para a ADSE e ainda não a tem, **não se avança como se tivesse**. Explica-se o passo em falta e marca-se o que for preciso. Prometer um reembolso que depois não acontece destrói a confiança.

GUARDA-SE aqui	NÃO se guarda aqui
Ficha clínica — avaliações, sessões e evolução de cada paciente, no software de gestão.	Palavras-passe e acessos — vão para o cofre, sempre.
Consentimentos — assinados e associados à ficha do paciente.	Dados de saúde em ficheiros soltos — nunca no ambiente de trabalho nem em telemóveis pessoais.
Registo de decisões — data, decisão, porquê. Elimina o «porque é que fizemos assim?».	Fotografias clínicas sem consentimento — não se tiram nem se guardam.
Aprendizagens e boas práticas — o que resulta bem e serve para os próximos.	Conversas de pacientes — não se comentam fora da clínica, nunca.
Perguntas frequentes — pergunta respondida 2x ganha resposta-tipo.	

NORMA DE NOMES DE FICHEIROS (DUAS REGRAS, SEM EXCEÇÕES)

Notas datadas (reuniões, decisões, relatórios): **AAAA-MM-DD — Tipo — Nome**. Ex.: «2026-07-21 — Reunião — Equipa Clínica».

Notas permanentes (protocolos, fichas de serviço): **Tipo — Nome**. Ex.: «Protocolo — Avaliação Inicial», «Serviço — Osteopatia».

A consistência é o que permite a qualquer pessoa encontrar tudo em segundos — incluindo tu daqui a 6 meses.

DADOS DE SAÚDE SÃO CATEGORIA ESPECIAL

A ficha clínica é a informação mais sensível que existe. Só se acede ao que se precisa para cuidar, nunca por curiosidade. Cada acesso fica registado. Consultar a ficha de alguém sem motivo de trabalho é uma falha grave — mesmo que seja um conhecido.

Os teus 2 reportes fixos

Reporte	Quando	O que contém (3 linhas chegam)
Check-in diário	Fim do dia, no canal interno	O que correu bem · o que ficou pendente · o que preciso para amanhã.
Resumo semanal	Sexta-feira, antes de sair	Semana em números (consultas, faltas, reembolsos) · pendentes · riscos à vista.

Como reportar um problema (o método dos 5 pontos)

1. **O quê:** o que aconteceu, em factos («o portal da ADSE não aceitou 3 reembolsos»).
2. **Quando:** desde quando, e como deste conta.
3. **Impacto:** quem é afetado (paciente? agenda? faturação? segurança?).
4. **O que já tentaste:** plano B ativado? protocolo consultado?
5. **Proposta:** o que sugeres fazer. Mesmo que esteja errada, poupa metade da conversa.

CULTURA DE ERRO — LÊ ISTO DUAS VEZES

Erros reportados cedo são baratos; erros escondidos são caros — e, em saúde, podem ser perigosos. Aqui **nunca ninguém é castigado por reportar um erro próprio no dia em que acontece** — a revisão pergunta sempre «o que falhou no sistema?», não «quem falhou?». O que quebra a confiança é esconder, não errar.

Os indicadores do teu trabalho (o que a clínica acompanha)

Indicador	Pergunta a que responde	Sinal de alarme
Pontualidade da agenda	Os pacientes são atendidos à hora?	Atrasos repetidos sem aviso
Faltas (no-show)	Estamos a perder horários?	Subida de faltas sem seguimento
Registos completos	Cada sessão ficou registada?	Fichas por preencher ao fim do dia
Satisfação do paciente	As pessoas sentem-se cuidadas?	Queixas repetidas sobre o mesmo
Melhorias propostas	Estás a fortalecer o sistema?	Um mês sem nenhuma proposta

11

Rotinas e Revisões

Os teus rituais fixos. São o que impede o dia de descarrilar.

ABERTURA

10 min · todos os dias

Abrir o espaço e os sistemas · conferir a agenda · confirmar que os gabinetes estão higienizados e prontos · escrever as 3 prioridades.

FIM DO DIA

10 min · todos os dias

Fecho de caixa · check-in diário no canal interno (Módulo 10) · confirmar que todas as sessões do dia estão registadas.

SEMANAL

30 min · sexta ao fim do dia

Resumo semanal (Módulo 10) · conferir reembolsos submetidos · rever stock de consumíveis · bloco administrativo.

MENSAL

60 min · com o responsável

Participas na revisão da clínica: trazes o teu resumo do mês, 1 melhoria de protocolo proposta e a lista de tarefas repetidas 3x (candidatas a simplificar).

PORQUE É QUE ISTO FUNCIONA

15 minutos de ritual por dia poupam horas de confusão por semana. As rotinas não são burocracia: são a razão pela qual aqui ninguém sai tarde a «apagar fogos» — os fogos são apanhados em pequenos, na revisão seguinte, antes de chegarem ao paciente.

OS RITUAIS DE HIGIENE E SEGURANÇA NÃO TÊM EXCEÇÃO

Higienizar o gabinete e o material entre pacientes, lavar as mãos, verificar a validade do material clínico — são rituais fixos, não «quando der». Fazem parte da abertura, de cada consulta e do fecho. É assim que se cuida sem riscos.

A tua primeira semana (o plano oficial)

- Dias 1-2:** acessos configurados (Módulo 00) + ler os Módulos 00, 04 e 13 + os protocolos da tua função.
- Dias 3-5:** acompanhar e executar tarefas reais **com supervisão**. As dúvidas que levatares são melhorias a registar nos protocolos — é o Teste dos 60 Anos em ação.
- Semana 2:** executas sozinho(a); o responsável revê apenas com a checklist de qualidade.

Os 3 níveis de autonomia

Nível	O que significa	Como se chega lá
Nível 1 Executar	Executas protocolos com revisão total antes de chegar ao paciente. É onde todos começam.	É onde todos começam.
Nível 2 Autonomia	Executas com revisão por amostragem; comunicas com pacientes dentro das regras do Módulo 04.	4+ semanas de checklists completas, zero imprevistos e registos sempre em dia.
Nível 3 Dono de área	És dono(a) de um protocolo ou área: manténs o protocolo atualizado, integras quem entra, apoias o Nível 1.	Melhorias aceites com regularidade + domínio comprovado da área.

O TEU CURRÍCULO INTERNO

Aqui, crescer não depende de «dar nas vistas»: depende de coisas que ficam escritas. Melhorias de protocolo aceites, checklists completas, registos em dia e pacientes satisfeitos são o teu histórico — visível, justo e à prova de esquecimento. O sistema que te forma é o mesmo que te promove.

RESPONSABILIDADES SEM REUNIÕES

Cada protocolo tem o campo **responsavel**. Esse campo é o mapa de quem faz o quê — se tens uma dúvida sobre uma área, o dono do protocolo é a pessoa a quem perguntar. Quando fores dono(a) de um protocolo, o teu nome estará lá.

Dados, acessos e sigilo

- **Tudo no cofre:** palavras-passe, chaves e acessos. Recebes acesso apenas ao que precisas.
- **Verificação em 2 passos (2FA)** ativa em todas as contas de trabalho — configura-se no dia 1.
- **Sigilo profissional:** nada do que vês ou ouves sobre um paciente sai da clínica — durante e depois da colaboração.
- **Só se acede ao que se precisa:** a ficha de um paciente abre-se para o cuidar, nunca por curiosidade.

O QUE NUNCA FAZER (LISTA VERMELHA)

Nunca enviar palavras-passe por email ou mensagem. Nunca usar contas ou números pessoais para pacientes. Nunca guardar dados de saúde fora do software de gestão. Nunca apagar registos clínicos. Nunca falar de pacientes fora da clínica — estamos obrigados ao sigilo pelo RGPD e pelo dever profissional. Nunca dar conselhos clínicos fora da tua função. Nunca reutilizar material de uso único nem saltar a higienização.

Segurança clínica — o cuidado sem riscos

- **Higienização** de gabinete e material entre todos os pacientes — sem exceção.
- **Consentimento e contraindicações** verificados antes de qualquer intervenção.
- **Mala de primeiros socorros e saídas de emergência** conhecidas por todos, desde o dia 1.
- **Incidentes** (quedas, reações, mal-estar) — assistir, avisar o profissional e registar no próprio dia.

Se uma ferramenta falhar

Falha	O que fazes
Software de gestão em baixo	Passar à agenda e registos em papel; avisar o responsável; passar tudo para o sistema quando voltar.
Terminal de pagamento em baixo	Combinar pagamento alternativo, registar e emitir o recibo depois; nunca dispensar o registo.
Portal de reembolsos indisponível	Faturar particular e entregar recibo para o paciente submeter mais tarde.
Computador perdido / avariado	Avisar imediatamente; os dados estão no sistema central, não na máquina.

CONFIDENCIALIDADE

Tudo o que vês aqui — pacientes, dados, processos, este manual — é confidencial e propriedade da Clínica Marques dos Santos. Vale durante e depois da colaboração. Em troca, o sistema protege-te a ti: o que está escrito e seguido defende-te sempre.

Ficha de Paciente (consulta antes de qualquer contacto)

```

---
tipo: paciente
estado: ativo          # novo | ativo | em seguimento | alta
nome:
data_nascimento:
contacto:
canal_unico: telefone # o ÚNICO canal para contacto
entidade: [ADSE | SAMS | seguro | particular]
consentimento: sim    # confirmar ANTES de tratar
---
## Motivo e objetivos
## Antecedentes e contraindicações
## Episódios e planos
## Histórico de contactos (mais recente primeiro)

```

Ficha de Episódio / Sessão (a tua checklist vive aqui)

```

---
tipo: episodio
estado: em tratamento # ver os 7 estados do Módulo 03
paciente: "[[Paciente - Nome]]"
especialidade: "[[Serviço - Fisioterapia]]"
profissional:
reavaliacao: a cada 4 sessões
---
## Avaliação inicial
## Plano e objetivos
## Registo de sessões (data - o que se fez - resposta)
## Reavaliações e alta

```

Resumo de consulta (para o paciente, quando aplicável)

Hoje ficou assim: 1) [o que foi feito] · 2) [o que fazer em casa] · 3) [sinais de alerta a vigiar]. A próxima sessão fica marcada para [data]. Qualquer dúvida, contacte-nos por [canal oficial]. Estamos consigo.

Checklist de alta

- ☐ Objetivos revistos com o paciente.
- ☐ Recomendações e plano de manutenção entregues.
- ☐ Recibos e reembolsos em dia.
- ☐ Estado do episódio atualizado na ficha.
- ☐ Reavaliação futura proposta, se fizer sentido.



Perguntas frequentes do colaborador

As dúvidas que toda a gente tem nas primeiras semanas — respondidas de uma vez.

Pergunta	Resposta
«Não percebo um passo de um protocolo. E agora?»	Pára, não improvises. Pergunta ao dono do protocolo (campo «responsavel») e regista a dúvida no Registo de melhorias — acabaste de melhorar o manual.
«Um paciente pede-me um conselho clínico e eu não sou o profissional.»	«Boa pergunta — quem o pode responder com rigor é o profissional; vou encaminhar.» Nunca inventes um conselho de saúde.
«Fiz asneira. Digo já ou tento resolver primeiro?»	Se houver risco para o paciente, assiste primeiro e chama o profissional. Depois reporta no próprio dia com o método dos 5 pontos (Módulo 10).
«O paciente escreveu-me no meu número pessoal.»	Responde uma vez, simpático(a), reencaminhando para o canal oficial: «para o acompanharmos bem, respondemos por [canal]». Regista na ficha.
«Tenho uma ideia para fazer diferente do protocolo.»	Ótimo — mas primeiro executa como está escrito, depois propõe a melhoria com o porquê. Se for aceite (e validada, se for clínica), muda para todos.
«O paciente quer ser atendido já e não há vaga.»	A regra protege todos: não se sobrepõem consultas. «Vejo a primeira disponível e ligo-lhe ainda hoje.»
«Acabei as minhas tarefas mais cedo.»	Por ordem: rever registos do dia · higienizar e preparar gabinetes · propor 1 melhoria · perguntar onde ajudar.
«Esqueci-me de como se faz X.»	Perfeito — é para isso que o sistema existe. Procura o protocolo. Se não existir, encontraste um buraco no manual: regista-o.

Mapa rápido — «onde encontro...?»

Guarda esta página. Nos primeiros tempos, é a que mais vais consultar.

Procuro...	Está em...
As instruções de uma tarefa	Biblioteca › Protocolos — e a checklist copia-se para a ficha
O estado e o plano de um paciente	Software de gestão › ficha do paciente / episódio (Módulo 03)
O contacto e o canal oficial de um paciente	Ficha do paciente (campo canal_unico)
Uma palavra-passe ou acesso	Cofre de acessos — nunca em notas nem em mensagens
O que fazer quando um sistema falha	«Se uma ferramenta falhar» (Módulo 13) + Registo de Erros
Os preços e o que inclui cada serviço	Tabela oficial em vigor + ficha do serviço (Módulos 02 e 06)
Como se pede um reembolso	Módulo 08 + Protocolo «Pedido de reembolso»
Templates (fichas, resumos, checklists)	Biblioteca › Modelos (Módulo 14)
O que ficou decidido (e porquê)	Biblioteca › Registo de Decisões
O significado de um termo	Glossário do Módulo 00
O que posso decidir sozinho(a)	Tabela «decidir vs. escalar» do Módulo 04



Os teus primeiros 30 dias

Quatro semanas, do primeiro acesso à tua primeira área de responsabilidade.

SEMANA 1 · APRENDER

- [] Acessos configurados: email, cofre com 2FA, software de gestão (Módulo 00)
- [] Módulos 00, 04 e 13 lidos + protocolos da tua função
- [] Glossário dominado — explicas ficha clínica, triagem e reembolso por palavras tuas
- [] Acompanhaste consultas reais do acolhimento à alta como observador(a)

SEMANA 2 · EXECUTAR COM REDE

- [] Tarefas reais executadas com supervisão
- [] Check-in diário e primeiro resumo semanal entregues (Módulo 10)
- [] Primeiras dúvidas registadas como propostas de melhoria
- [] Rotinas de abertura e fecho já automáticas (Módulo 11)

SEMANA 3 · VOAR COM REVISÃO

- [] Tarefas reais entregues por ti, revistas por amostragem
- [] Primeira comunicação com paciente dentro das regras do Módulo 04
- [] 1 melhoria de protocolo proposta formalmente
- [] Checklist de qualidade completa em todas as tarefas

SEMANA 4 · ASSUMIR

- [] Participação na revisão mensal com o teu resumo e propostas
- [] Lista de tarefas repetidas 3x entregue (candidatas a simplificar)
- [] Retrospectiva de integração: o que faltou a este manual?
- [] Definição, com o responsável, da tua primeira área rumo ao Nível 2

As 10 regras de ouro — o manual numa página

Se só memorizares uma página deste manual, que seja esta.

1	Tudo entra na agenda ou na ficha. Nada fica «na cabeça».
2	Se não está escrito, não existe — cada sessão regista-se no próprio dia.
3	Lê o protocolo inteiro antes de começar. Se um passo não bater certo, pára e pergunta.
4	Sem avaliação e consentimento não há tratamento; sem checklist completa não há alta.
5	Um canal oficial por paciente, empatia primeiro, resposta em 1 dia útil.
6	Diagnósticos, preços e promessas escalam sempre — «deixe-me confirmar e respondo hoje».
7	Palavras-passe só no cofre. Dados de saúde só no software de gestão.
8	Higieniza sempre. Erros reportam-se no próprio dia. Esconder é a única falha grave.
9	Tarefa repetida 3 vezes = proposta de melhoria. As tuas dúvidas são melhorias por escrever.
10	A simplicidade vence sempre — e o sistema que segues é o mesmo que te protege e te promove.

Nota final — o contrato deste manual

- Simplicidade primeiro.** Se leres algo aqui e não perceberes, o manual é que está mal — diz-nos e corrigimos. É assim que ele melhora.
- Melhoria contínua.** Cada atendimento pode melhorar uma linha deste documento. Melhoria pequena e constante vence a reforma heroica ocasional.
- O sistema protege-te.** Quem segue os protocolos, marca as checklists e reporta cedo nunca depende de memória nem leva culpas injustas — o que está escrito defende-te.

Clínica Marques dos Santos · Manual do Colaborador v1.0 · Documento vivo — as tuas dúvidas são as próximas melhorias.